GİZLİ BONUS

Kritik Bulgu Bildirimi: Telefonda Nasıl Söylenir

Kritik bulguyu gördünüz; şimdi telefonda 30 saniyede, eksiksiz ve yanlış anlaşılmadan söylemeniz gerekiyor. Durum · Öykü · Değerlendirme · Öneri yapısı, 12 hazır konuşma ve raporda neyin kaydedileceği.

İçindekiler

Kritik bulgu nedir, neden telefon?

Dört adımlı konuşma: Durum · Öykü · Değerlendirme · Öneri

Konuşmadan önce ve sonra

12 hazır konuşma örneği

Raporda ne kaydedilir

Zor durumlar

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Kritik bulgu nedir, neden telefon?

ÖZETLE adımının son halkası: acil bulguyu bildir.

> *Rapor sisteme düştüğünde değil, doğru hekim bulguyu öğrendiğinde iş biter.*

Kritik bulgu, hemen müdahale edilmezse hastanın hayatını veya bir organını tehdit edebilecek bulgudur. Hangi bulguların telefonla bildirileceğine kurumunuzun listesi karar verir; aşağıdakiler bu listelerde sık yer alan örneklerdir.

Nöro ve omurga

İntrakraniyal kanama · kitle etkisi ve herniasyon · akut inme bulguları · akut hidrosefali · spinal kord basısı · instabil omurga kırığı

Toraks

Tansiyon lehine pnömotoraks · pulmoner emboli · aort diseksiyonu · yanlış konumda tüp veya kateter · tamponad şüphesi

Abdomen ve pelvis

Serbest hava · iskemi bulgulu obstrüksiyon · rüptür bulgulu AAA · aktif kanama · ektopik gebelik · testis veya over torsiyonu

Çocuk ve diğer

İnvajinasyon · özofagusta yabancı cisim veya düğme pil · beklenmeyen ve klinik kararı değiştirecek her bulgu

Asistan olarak sizin kuralınız

Bir bulgunun kritik olup olmadığından emin değilseniz bildirin ve hocanıza danışın. Bölümünüzün bildirim prosedürü bu materyalden önce gelir.

BÖLÜM 2

Dört adımlı konuşma

SBAR yapısının Türkçe karşılığı: Durum · Öykü · Değerlendirme · Öneri.

ADIM	NE SÖYLERSİNİZ	KALIP
D · Durum	Kim olduğunuz, hangi hasta, en önemli bulgu — tek cümlede.	«Radyoloji asistanı [adınız]. [Hasta adı, protokol no] için [tetkik]te [bulgu] var.»
Ö · Öykü	Tetkikin neden ve ne zaman çekildiği; istemdeki soru.	«[Klinik durum] ile [saat]'te çekilmiş; istem «[soru]».»
D · Değerlendirme	Bulgunun ciddiyeti: boyut, kitle etkisi, önceki tetkike göre değişim.	«[Ölçü/derece]; önceki tetkikte [yoktu/vardı].»
Ö · Öneri	Ne beklediğiniz ve geri okuma talebi.	«[Acil değerlendirme / ek tetkik] öneriyorum. Geri okuyabilir misiniz?»

Hasta kimliği: iki tanımlayıcı

Konuşmanın başında hastayı en az iki tanımlayıcıyla belirtin (ad soyad ve protokol numarası veya doğum tarihi). Benzer isimli hastalar en sık karışıklık nedenidir.

Geri okuma

Karşı taraftan bulguyu ve hastayı tekrar etmesini isteyin. Geri okuma, taraf ve hasta karışıklığını telefonda yakalamanın en basit yoludur.

BÖLÜM 3

Konuşmadan önce ve sonra

Telefonu açmadan önce 30 saniye hazırlık, kapattıktan sonra bir dakika kayıt.

Aramadan önce

- [ ] Hasta kimliği ve tetkik ekranınızda açık.
- [ ] İstemi yazan hekim veya o anda hastadan sorumlu hekim belirlendi.
- [ ] Bulgu, taraf ve ölçü bir kağıda veya rapor taslağına yazıldı.
- [ ] Önceki tetkik kontrol edildi (yeni mi, bilinen mi?).
- [ ] Gerekiyorsa uzman hocanız haberdar edildi.

Kapattıktan sonra

- [ ] Bildirim raporda kaydedildi: saat, kime (unvan, birim), hangi yolla.
- [ ] Geri okuma yapıldığı kaydedildi.
- [ ] Kurumunuzun kritik bulgu kayıt sistemi varsa oraya da girildi.
- [ ] Rapor gecikmeden sisteme girildi.

BÖLÜM 4

12 hazır konuşma örneği

Köşeli parantezleri doldurun; cümleleri kendi konuşma dilinize uyarlayın, sırayı koruyun.

01 Tansiyon pnömotoraks lehine bulgular

Yatak başı akciğer grafisi, yoğun bakım.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. [Yatak/servis] hastanız [hasta adı, protokol no] için [saat]'te çekilen akciğer grafisinde [sağ] geniş pnömotoraks ve mediastende karşı tarafa itilme görüyorum.
Ö · ÖYKÜ	Hasta [entübe/girişim sonrası]; istem «[istemdeki soru]».
D · DEĞERLENDİRME	Bulgular tansiyon pnömotoraks lehine. Önceki grafide pnömotoraks [yoktu].
Ö · ÖNERİ	Hastayı hemen değerlendirmenizi öneriyorum. Bulguyu geri okuyabilir misiniz?

Rapora kayıt: «[Sağ] geniş pnömotoraks ve tansiyon lehine radyolojik bulgular. [Saat]'te [unvan, birim] hekimine telefonla bildirilmiş, bilgi geri okunarak teyit edilmiştir.»

02 Akut epidural hematom

Kafa travması, acil servis, kontrastsız beyin BT.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. Acil serviste [hasta adı, protokol no] için beyin BT'de [sağ temporal] akut epidural hematom var.
Ö · ÖYKÜ	Kafa travması sonrası çekilmiş; istem «kanama?».
D · DEĞERLENDİRME	En kalın yeri [.. mm], orta hat şifti [.. mm]; üzerinde [lineer kırık] var.
Ö · ÖNERİ	Acil beyin cerrahisi değerlendirmesi gerekebilir; raporu şimdi sisteme giriyorum.

Rapora kayıt: «[Sağ temporal] akut epidural hematom, [.. mm] orta hat şifti. [Saat]'te acil servis [unvan] hekimine telefonla bildirilmiştir; geri okuma yapılmıştır.»

03 Subaraknoid kanama

Ani başlayan şiddetli baş ağrısı, kontrastsız beyin BT.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. [Hasta adı, protokol no] için beyin BT'de subaraknoid kanama görüyorum.
Ö · ÖYKÜ	Ani başlayan baş ağrısı ile çekilmiş; travma öyküsü [yok].
D · DEĞERLENDİRME	Kanama [bazal sisternlerde] yaygın; hidrosefali [yok/var].
Ö · ÖNERİ	Anevrizma açısından BT anjiyografi öneriyorum; ilgili birimle değerlendirmenizi rica ediyorum.

Rapora kayıt: «Subaraknoid kanama; BT anjiyografi önerilir. [Saat]'te [unvan, birim] hekimine bildirilmiştir.»

04 Akut iskemik inme · hiperdens MCA

İnme kodu, kontrastsız beyin BT.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. İnme protokolündeki [hasta adı, protokol no] için BT'de kanama yok; [sol] MCA'da hiperdens arter işareti ve erken iskemi bulguları var.
Ö · ÖYKÜ	Semptom başlangıcı istemde [saat] olarak belirtilmiş.
D · DEĞERLENDİRME	Kanama izlenmedi; [sol] MCA sulama alanında erken iskemik değişiklikler.
Ö · ÖNERİ	BT anjiyografi ile değerlendirme öneriyorum. Bulguyu geri okuyabilir misiniz?

Rapora kayıt: «İntrakraniyal kanama yok; [sol] MCA'da hiperdens arter işareti ve erken iskemi bulguları. İnme protokolü kapsamında [saat]'te [unvan, birim] hekimine bildirilmiştir.»

05 Pulmoner tromboemboli

BT pulmoner anjiyografi, servis hastası.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. [Servis] hastanız [hasta adı, protokol no] için BT pulmoner anjiyografide bilateral pulmoner emboli var.
Ö · ÖYKÜ	Dispne ve taşikardi ile istenmiş.
D · DEĞERLENDİRME	Emboliler [lober ve segmental] düzeyde; sağ ventrikül yüklenmesi bulguları [var/yok].
Ö · ÖNERİ	Hastayı değerlendirmenizi öneriyorum; rapor sistemde.

Rapora kayıt: «Bilateral akut pulmoner tromboemboli; sağ ventrikül yüklenmesi bulguları [var/yok]. [Saat]'te [unvan, birim] hekimine telefonla bildirilmiştir.»

06 Aort diseksiyonu

Göğüs-sırt ağrısı, BT anjiyografi.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. Acil serviste [hasta adı, protokol no] için BT anjiyografide aort diseksiyonu var; asendan aorta [tutulmuş/tutulmamış].
Ö · ÖYKÜ	Ani başlayan göğüs ve sırt ağrısı ile istenmiş.
D · DEĞERLENDİRME	Diseksiyon [asendan aortadan] başlayıp [düzey]'e uzanıyor; perikardiyal efüzyon [yok/var].
Ö · ÖNERİ	Acil kalp-damar cerrahisi değerlendirmesi gerekebilir; bulguyu geri okuyabilir misiniz?

Rapora kayıt: «[Stanford A] aort diseksiyonu. Acil bulgu; [saat]'te acil servis [unvan] hekimine bildirilmiş, geri okuma ile teyit edilmiştir.»

07 Pnömoperitoneum

Akut karın, ayakta akciğer grafisi / abdomen BT.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. [Hasta adı, protokol no] için tetkikte diyafram altında serbest hava görüyorum.
Ö · ÖYKÜ	Karın ağrısı ile istenmiş; istemde yakın zamanda cerrahi öyküsü [belirtilmemiş].
D · DEĞERLENDİRME	Serbest hava [bilateral]; BT'de olası perforasyon yeri [lokalizasyon].
Ö · ÖNERİ	Acil cerrahi değerlendirme öneriyorum. Yakın zamanda cerrahi veya girişim öyküsü var mı?

Rapora kayıt: «Pnömoperitoneum; içi boş organ perforasyonu lehine. [Saat]'te [unvan, birim] hekimine telefonla bildirilmiştir.»

08 Yanlış konumda nazogastrik tüp

Beslenme öncesi yatak başı grafi.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. [Yatak/servis] hastanız [hasta adı, protokol no] için NG tüp kontrol grafisinde tüp ucu [sağ ana bronş] projeksiyonunda.
Ö · ÖYKÜ	Beslenme başlanmadan önce tüp yeri kontrolü istenmiş.
D · DEĞERLENDİRME	Tüp uygun konumda değil; [pnömotoraks yok].
Ö · ÖNERİ	Tüp kullanılmadan önce yerinin düzeltilmesini öneriyorum. Bulguyu geri okuyabilir misiniz?

Rapora kayıt: «Nazogastrik tüp ucu [sağ ana bronş] projeksiyonunda, uygun konumda değil. Kullanılmadan önce [saat]'te [unvan, birim] hekimine/hemşiresine bildirilmiştir.»

09 Testis torsiyonu

Ani skrotal ağrı, skrotal Doppler USG.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. [Hasta adı, protokol no] için skrotal Doppler'de [sol] testiste akım izlenmiyor.
Ö · ÖYKÜ	Ani başlayan skrotal ağrı ile istenmiş; başlangıç [saat].
D · DEĞERLENDİRME	Bulgular torsiyon ile uyumlu; karşı testis doğal.
Ö · ÖNERİ	Acil üroloji değerlendirmesi öneriyorum.

Rapora kayıt: «[Sol] testis torsiyonu ile uyumlu bulgular. Acil bulgu; [saat]'te [unvan, birim] hekimine telefonla bildirilmiştir.»

10 Ektopik gebelik lehine bulgular

Gebelik testi pozitif, pelvik USG.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. [Hasta adı, protokol no] için pelvik USG'de uterin gebelik izlemiyorum; [sağ] adneksiyel kitle ve serbest sıvı var.
Ö · ÖYKÜ	Gebelik testi pozitif, pelvik ağrı ile istenmiş.
D · DEĞERLENDİRME	Bulgular ektopik gebelik lehine; serbest sıvı [ekojen içerikli].
Ö · ÖNERİ	Acil kadın doğum değerlendirmesi öneriyorum. Bulguyu geri okuyabilir misiniz?

Rapora kayıt: «Uterin gebelik izlenmedi; [sağ] adneksiyel kitle ve serbest sıvı ile ektopik gebelik lehine bulgular. [Saat]'te [unvan, birim] hekimine bildirilmiştir.»

11 Spinal kord basısı

Bilinen malignite, sırt ağrısı, torakal MR.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. [Hasta adı, protokol no] için torakal MR'da [T..] düzeyinde spinal kord basısı var.
Ö · ÖYKÜ	Bilinen malignite ve yeni sırt ağrısı ile istenmiş.
D · DEĞERLENDİRME	Bası epidural tümör yayılımı ile uyumlu olabilir; kordda sinyal değişikliği [var/yok].
Ö · ÖNERİ	Acil değerlendirme öneriyorum; tüm spinal görüntüleme [yapıldı/gerekebilir].

Rapora kayıt: «[T..] düzeyinde epidural tümör yayılımı ile uyumlu olabilecek lezyon ve spinal kord basısı. [Saat]'te [unvan, birim] hekimine telefonla bildirilmiştir.»

12 İnvajinasyon (çocuk)

Aralıklı karın ağrısı, batın USG.

D · DURUM	Radyoloji asistanı [adınız]. Çocuk acildeki [hasta adı, protokol no] için batın USG'de [ileokolik] invajinasyon görüyorum.
Ö · ÖYKÜ	Aralıklı karın ağrısı ve kusma ile istenmiş.
D · DEĞERLENDİRME	[Sağ abdomende] hedef görünümü; duvar akımı [korunmuş/azalmış], serbest sıvı [yok/var].
Ö · ÖNERİ	Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi öneriyorum.

Rapora kayıt: «[İleokolik] invajinasyon ile uyumlu bulgular. Acil bulgu; [saat]'te [unvan, birim] hekimine bildirilmiştir.»

BÖLÜM 5

Raporda ne kaydedilir

Yazılmayan bildirim, sonradan doğrulanamaz.

ÖĞE	ÖRNEK
Ne bildirildi	Sonuç'taki kritik bulgu, raporla aynı kelimelerle.
Saat	«[saat]'te» — tarih raporun kendisinden anlaşılmıyorsa tarih de.
Kime	Unvan ve birim: «acil servis nöbetçi hekimi», «[servis] sorumlu hekimi». İsim yazmak kurum pratiğinize bağlıdır.
Hangi yolla	Telefonla / yüz yüze.
Teyit	«Bilgi geri okunarak teyit edilmiştir.»

Kayıt cümlesi kalıbı

«[Bulgu]. [Saat]'te [unvan, birim] hekimine telefonla bildirilmiş, bilgi geri okunarak teyit edilmiştir.»

BÖLÜM 6

Zor durumlar

Telefon her zaman ilk aramada açılmaz.

DURUM	NE YAPARSINIZ
İstemi yazan hekime ulaşamıyorsunuz	Hastadan o anda sorumlu hekime veya birimin nöbetçisine ulaşın; kurumunuzun eskalasyon sırasını izleyin. Denemeleri ve saatlerini kaydedin; hocanıza haber verin.
Karşı taraf bulguyu zaten biliyor	Yine de kısaca bildirin ve «bilinen bulgu olarak teyit edildi» şeklinde kaydedin; önceki tetkike göre değişimi özellikle belirtin.
Bulgudan emin değilsiniz	Bildirimi geciktirmeyin; uzman hocanıza hemen danışın. Kesinlik düzeyini telefonda da açıkça söyleyin: «lehine», «şüpheli».
Konuşma uzuyor veya tartışmaya dönüyor	Dört adıma geri dönün, öneriyi tekrar edin ve hocanızı dahil edin. Klinik karar klinik ekibe aittir; sizin göreviniz bulgunun doğru ve zamanında iletilmesidir.
Gece nöbetinde ön rapor	Kritik bulgu ön raporda da aynı şekilde bildirilir ve kaydedilir; kesin rapor sonrası değişiklik olursa yeniden bildirilir.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi Ana materyal · 120 Hazır Rapor Şablonu'na dönün. Acil bulgu şablonlarının Sonuç alanındaki bildirim cümlelerini bu bölümdeki kayıt kalıbıyla doldurun.

Acil bulgu sonuç cümlelerinin tamamı için **Bonus 1 · 200 Sonuç Cümlesi Bankası**'ndaki «Acil» etiketli cümlelere bakabilirsiniz.